

Activación Conductual — Guía clínica del protocolo

Fundamento, ciclo de mantenimiento y errores frecuentes

La Activación Conductual (AC) es una intervención basada en evidencia que trabaja con conducta concreta, no con pensamientos o emociones directamente. Parte de un supuesto central: no se espera a sentir ganas para actuar — se actúa primero, y el ánimo suele mejorar después.

EL CICLO DE EVITACIÓN-DEPRESIÓN

Malestar → inactividad/evitación → menor contacto con refuerzo positivo → profundización del malestar. La AC interviene directamente en el segundo eslabón: introducir conducta activa rompe el ciclo independientemente del estado de ánimo previo.

CÓMO INTRODUCIR EL PROTOCOLO EN SESIÓN

- 1 Psicoeducar sobre el ciclo antes de pedir cualquier tarea — el paciente necesita entender el por qué.
- 2 Construir junto al paciente un inventario de actividades por categoría (placer, logro, movimiento, vínculo, cuidado personal).
- 3 Ordenar las actividades elegidas en una jerarquía de dificultad creciente.
- 4 Programar la primera actividad con horario y contexto específico — nunca como intención general.
- 5 Revisar el resultado real en la siguiente sesión, sin penalizar el incumplimiento parcial.

ERRORES COMUNES A EVITAR

- ✗ Esperar a que el paciente “sienta ganas” antes de planificar la actividad.
- ✗ Elegir actividades demasiado ambiciosas para el nivel de energía actual.
- ✗ Tratar el no cumplimiento como fracaso del paciente en lugar de dato clínico útil.
- ✗ Omitir el registro — sin registro no hay forma de notar el cambio gradual.

■ Clave clínica

La AC es especialmente indicada en depresión moderada con marcada anhedonia y retraimiento conductual. En depresión grave con riesgo, priorizar primero la evaluación de seguridad antes de iniciar cualquier plan de activación.